Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Стадии 2

2.3 Степень тяжести 3

2.4 Клиническая картина 3

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата 3

3. Диагностика 3

3.1 Маркеры бактериального воспаления 4

4. Лечение 4

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия 4

4.2 Показания к антибактериальной терапии 5

4.3 Выбор антибактериального препарата 5

4.4 Суточные дозы 6

4.5 Местная и вспомогательная терапия 7

4.6 Хирургическое лечение 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Острый средний отит (ОСО) является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу. Заболевание проявляется болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением из уха.
- Диагноз устанавливается при одновременном наличии острого начала, воспалительных изменений барабанной перепонки и признаков выпота в барабанной полости: выбухания или снижения подвижности барабанной перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.
- У детей до 2 лет клинические признаки ОСО во всех случаях служат основанием для антибактериальной терапии. Независимо от возраста она необходима при гнойной форме, сохранении симптомов более 72 часов, рецидивирующем течении, отягощающей сопутствующей патологии, а также при невозможности повторного осмотра пациента.
- Препаратом первой линии является амоксициллин. При отсутствии эффекта в течение 3 дней он заменяется на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Продолжительность курса составляет 7–10 дней.
- Для обезболивания используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном допустимы только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
- Через 3–4 недели пациента повторно осматривают с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы своевременно выявить экссудативный средний отит.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха (барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу) и проявляющимся одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим считается отит при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

Затянувшимся считается отит, при котором симптомы воспаления среднего уха сохраняются в течение 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибактериальной терапии.

У детей возможны возбуждение, раздражительность, рвота и диарея. Заболевание, как правило, длится не более трёх недель.

2.2 Стадии

1) острый евстахеит; 2) острое катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия острого гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия острого гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В стадии острого катарального воспаления барабанная перепонка гиперемирована, утолщена, опознавательные знаки определяются с трудом или не определяются.

В стадии острого гнойного воспаления боль в ухе резко усиливается, температура тела достигает фебрильных значений; барабанная перепонка ярко гиперемирована, выбухает, опознавательные знаки

не определяются, возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию барабанной перепонки в наружный слуховой проход поступает гнойное отделяемое.

В репаративной стадии жалобы практически отсутствуют, цвет и толщина барабанной перепонки восстанавливаются, перфорация в большинстве случаев закрывается рубцом, однако восстановление слизистой оболочки среднего уха ещё не наступило.

2.3 Степень тяжести

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Осложнения отсутствуют	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Выбухание барабанной перепонки отсутствует	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Непродолжительная боль в ухе, хорошо купируется лекарственными средствами	Выраженный болевой синдром (у детей раннего возраста проявляется изменением поведения), плохо купируется или не купируется лекарственными средствами
Общее состояние не изменено: сон, аппетит и активность не нарушены	Общее состояние изменено
Нормальная температура тела или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура тела выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

У детей старше 2 лет ключевым симптомом является остро возникшая боль в ухе на фоне воспалительных изменений барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, снижение подвижности при пневмоотоскопии), в постперфоративной стадии отмечается оторея. У детей раннего возраста большее диагностическое значение имеют выбухание барабанной перепонки и изменения поведения: беспокойство, отказ от еды, ребёнок теребит и трёт ухо.

Взрослые пациенты чаще предъявляют жалобы на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Снижение слуха носит кондуктивный характер; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата

Возбудителя в ряде случаев можно предположить по клинической картине. При сочетании отита с конъюнктивитом наиболее вероятным возбудителем является H. influenzae. Стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей характерно для S. pyogenes, нарастающая боль, лихорадка и спонтанная перфорация характерны для S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

Диагноз устанавливается при одновременном наличии трёх признаков: острого начала заболевания, воспалительных изменений барабанной перепонки (гиперемии, инфильтрации) и выпота в барабанной полости (выбухания, снижения подвижности барабанной перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.

Осмотр врачом-оториноларингологом необходим каждому пациенту с ОСО.

При отсутствии реактивных изменений барабанной перепонки её подвижность оценивается при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (более 10 дней), рецидивирующем отите, а также для исключения нейросенсорной тугоухости.

Развёрнутый общий анализ крови выполняют всем пациентам.

Уровень прокальцитонина определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

3.1 Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороговые значения для гнойного отита: лейкоциты >15×10^9/л (ППР 85%, ПОР 64%), С-реактивный белок (СРБ) >30 мг/л (ППР 79%, ПОР 52%), прокальцитонин (ПКТ) >2 нг/мл (ППР 94%, ПОР 74%). Таблица в PDF представлена изображением; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое направляют на микробиологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам при парацентезе или наличии отделяемого из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем течении отита.

Компьютерная томография (КТ) височных костей необходима при затяжном течении (более 10 дней), выраженном ухудшении состояния, а также при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если выполнить КТ невозможно, по тем же показаниям прибегают к рентгенографии височных костей в проекциях по Шюллеру и Майеру.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия

При болевом синдроме и лихорадке применяют НПВП или парацетамол. Препараты принимают разово: при боли в ухе или температуре тела выше 38,5 °C, а при фебрильных судорогах в анамнезе уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет допустимо назначение только парацетамола (до 60 мг/кг в сутки, 10–15 мг/кг на приём) или ибупрофена (до 30 мг/кг в сутки, 8–10 мг/кг на приём).

Местное обезболивание обеспечивают ушные капли с лидокаином и феназоном; их применение допустимо только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.

4.2 Показания к антибактериальной терапии

Системная антибактериальная терапия проводится при наличии показаний.

Показание	Когда
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при наличии клинических признаков ОСО
Гнойная форма независимо от возраста	Перфорация барабанной перепонки с гнойным отделяемым; при отсутствии перфорации болевой синдром, не купируемый анальгетиками, в сочетании с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков и выбуханием барабанной перепонки
Сохранение симптомов более 72 часов независимо от возраста	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО в течение 72 часов и более от начала заболевания
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Невозможность повторного осмотра	Отсутствует возможность контрольного осмотра с отоскопией врачом-оториноларингологом или врачом общей практики

4.3 Выбор антибактериального препарата

Препаратом первой линии является амоксициллин при условии, что пациент не принимал его в течение последних 30 дней, а гнойный конъюнктивит и непереносимость аминопенициллинов отсутствуют.

Препаратами второй линии являются защищённые пенициллины и цефалоспорины III поколения. При отсутствии эффекта от амоксициллина в течение 3 дней он заменяется на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите стартовыми препаратами являются амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим внутрь.

Макролиды у детей относятся к препаратам третьей линии; их применение оправдано только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, поскольку устойчивость пневмококка к ним превышает 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов альтернативой служат цефалоспорины III поколения: в амбулаторных условиях цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Продолжительность курса составляет 7–10 дней. Более длительные курсы требуются детям до 2 лет, пациентам с отореей и сопутствующими заболеваниями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс, как правило, составляет не менее 14 дней. Антибактериальную терапию не прекращают до купирования отореи.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не рекомендуются в связи с низкой активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки и высокой частотой нежелательных явлений.

В постперфоративной стадии системная антибактериальная терапия продолжается.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от приёма пищи)	0,5 г 3 раза в сутки без факторов риска[1]; 1,0 г 3 раза в сутки при факторах риска[2]	50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале приёма пищи)	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки	40–45 мг/кг в сутки в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г в сутки в 3 введения	90 мг/кг в сутки в 3 введения (при массе тела 4–40 кг); 60 мг/кг в сутки (при массе тела менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г в сутки в 4 введения	150–300 мг/кг в сутки в 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г в сутки в 1 введение	50–80 мг/кг в сутки в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (непосредственно после приёма пищи)	500 мг в сутки в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг в сутки в 2 приёма
Цефиксим	400 мг в сутки в 1 приём	8 мг/кг в сутки в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для приготовления суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг в сутки в 2 приёма	15 мг/кг в сутки в 2 приёма

[1] [2] Без факторов риска / при факторах риска устойчивости пневмококка: приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца; дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска продукции β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неэффективность терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине стандартная доза для детей составляет 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивости пневмококка 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

У детей до 3 лет амоксициллин применяют только в форме суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены к применению с 12 лет; для детей младше 12 лет с массой тела менее 40 кг предназначены гранулы, порошок для приготовления суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации барабанной перепонки купирование отореи ускоряют ушные капли на основе фторхинолонов или дексаметазона в комбинации с противомикробными средствами. Капли, содержащие аминогликозиды, и спиртосодержащие капли противопоказаны в связи с ототоксическим действием.

Ушные капли с норфлоксацином разрешены детям старше 1 года, с ципрофлоксацином с 15 лет. Капли с офлоксацином и дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами применяются у детей старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос используют во всех стадиях для восстановления проходимости слуховой трубы на срок не более 5–7 дней. Применение нафазолина не рекомендуется.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года допустимы только капли, после года по возможности переходят на дозированный назальный спрей.

Детям рекомендуется орошение полости носа изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. У детей дошкольного возраста от промывания полости носа большими объёмами растворов следует воздержаться, поскольку это повышает риск развития отита.

Муколитические препараты применяют у детей старше 2 лет. Перед назначением следует свериться с зарегистрированными показаниями в инструкции, поскольку не каждый муколитик, эффективный при патологии бронхов, пригоден для лечения отита.

4.6 Хирургическое лечение

Парацентез показан при выраженной клинической симптоматике и выбухании барабанной перепонки без перфорации, при болевом синдроме, не купируемом НПВП, а также при отсутствии улучшения через 48–72 часа антибактериальной терапии. Во всех сомнительных случаях решение принимается в пользу парацентеза.

Внутривисочные или внутричерепные осложнения требуют экстренной антромастоидотомии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

разделы 4–6 текста КР
Через 3–4 недели необходим повторный осмотр оториноларингологом с пневмоотоскопией или тимпанометрией для исключения экссудативного среднего отита.

Жалобы на снижение слуха после перенесённого отита служат поводом для консультации сурдолога-оториноларинголога.

В репаративной стадии проводятся продувание слуховых труб и пневмомассаж барабанных перепонок. Восстановление аэрации подтверждается объективными методами, в том числе тимпанометрией.

Консультация физиотерапевта рекомендуется в репаративной стадии.

Всем детям показана вакцинация против пневмококковой инфекции в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

При рецидивирующем отите в плановом порядке выполняется шунтирование барабанной полости (тимпаностомия).

Показаниями к экстренной госпитализации являются тяжёлое течение, отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии в течение 3–5 дней, а также прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Пациент выписывается при стабильно удовлетворительном состоянии на протяжении не менее 3 дней.

Более тяжёлое течение и высокий риск осложнений отмечаются у пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Риск развития отита повышен у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), аллергическим ринитом, а также у курильщиков, в том числе пассивных.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина в комментарии к рекомендации составляет 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивости пневмококка), тогда как в таблице 4 указано 50–60 мг/кг/сут.
- Для цефуроксима у взрослых в таблице 4 указано «500 мг/сут в 2 приёма»; дозу следует сверить с инструкцией в ГРЛС.
- Для ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (код ципрофлоксацина), тогда как выше по тексту для офлоксацина приведён код S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF представлена изображением; её значения перенесены вручную.
- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) с 15 лет; возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.